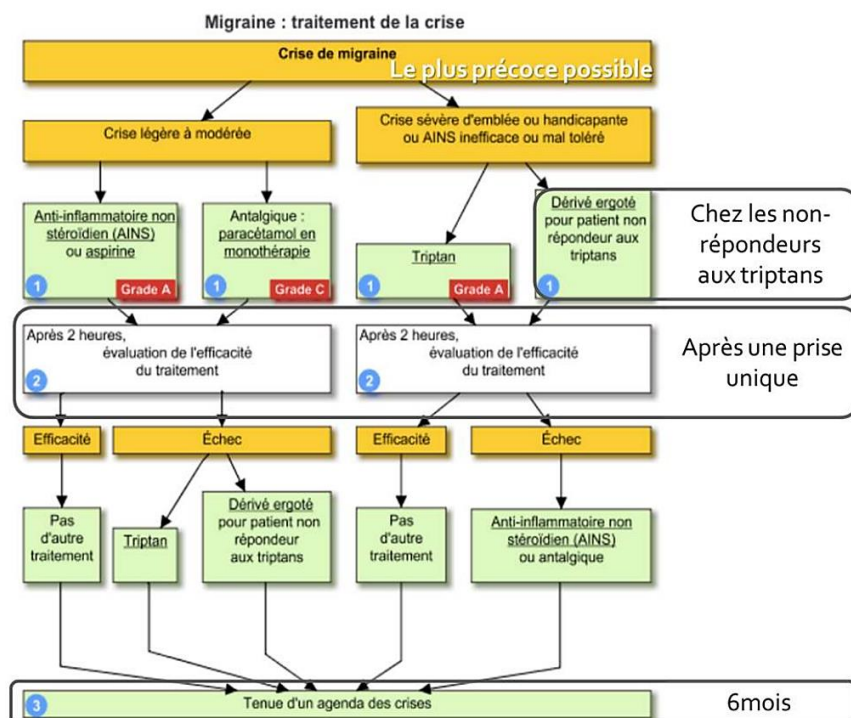


CHAPITRE 3 : MEDICAMENTS DE LA MIGRAINE

Introduction	
Généralités	
Définitions	➤ Migraine = céphalée la + fréquente : 12% pop (+ fréq chez femmes) ➤ <u>Diagnostic aisé</u> : • Céphalée pulsatile • Volontiers unilatérale • Nausées/vomissements, • Photo/phonophobie ➤ 25% migraines sont avec aura (= manifestations neuro focalisées avant ou pdt la céphalée) ➤ <u>Physiopathologie</u> : <i>imparfaitement comprise, 2 mécanismes</i> • La « dépolarisation envahissante » (spreading depression) => épuisement neuronal dans la zone cérébrale correspondant à la sémiologie de l'aura • Une anomalie de la vasomotricité des micro-vaisseaux encéphaliques dont le contrôle dépend du nerf trijumeau (5^{ème} paire crânienne) ➤ <u>TTT</u> : • Eradication des facteurs déclenchants des crises • TTT de la crise et parfois, TTT de fond, à visée prophylactique (> 2 crises/mois, retentissement socio-professionnel) • <u>TTT de la crise</u> : <i>de manière graduée</i> - 1) Médocs non spécifiques (antalgiques et AINS) - 2) Médocs spécifiques de la crise (triptans +++) • Volontiers associée à d'autres céphalées bénignes (tension, par abus d'antalgiques)
Migraine et Céphalée de tension	➤ <u>Migraine</u> : • 10-12% (6% H et 18% F) • Céphalées unilatérales • Pulsatiles modérées-sévères • Aggravées par l'effort • Nausées et/ou vomissements • Photophobie, phonophobie • Durée : 4-72h • 5 crises avec ces critères ➤ <u>Céphalées de tension</u> : • 20-30% • Céphalées constrictives pesantes, • Non pulsatiles, légères-modérées, bilatérales • Non aggravées par l'effort • Peu de nausées, pas de vomissement Sinus: pain is behind browbone and/or cheekbones  Cluster: pain is in and around one eye  Tension: pain is like a band squeezing the head  Migraine: pain, nausea and visual changes are typical of classic form  Most headaches are caused by muscle contraction, vascular problems, or both  

Associations possibles	➤ <u>Association céphalées de tension (psychogènes) et migraine : fréq et suspectée si</u> • Persistance de céphalées de fond (stt postérieure) entre accès migraineux céphalée • Après l'aura (intervalle libre < 60 min), parfois débutant avant/pdt l'aura • Personnalité anxieuse associée • Tension musculaire douloureuse des muscles de la nuque ➤ <u>Association céphalées et prises abusive de médoc :</u> • Céphalées induites par prise abusive de médocs • Surconso de médocs (spécifiques ou non de la migraine) : - Accoutumance avec majoration des céphalées - ↗ des doses • Cercle vicieux difficile à rompre : - Céphalées chroniques quotidiennes - Nécessite une hospitalisation pour sevrage  MIGRAINE ALGIE VASCULAIRE CEPHALEE DE TENSION SINUSITE
Stratégie pharmacologique (Diapo in english)	➤ <i>Therapy of migraine headaches is complicated by the variable responses among and within individual patients and by the lack of a firm understanding of the pathophysiology of the syndrome.</i> ➤ <i>The efficacy of anti-migraine drugs varies with the absence or presence of aura, duration of the headache, its severity and intensity, and as yet undefined environmental and genetic factors</i> ➤ <i>The pathogenesis of migraine headache is complex, involving both neural and vascular elements.</i> ➤ <i>Evidence suggesting that 5-HT is a key mediator in the pathogenesis of migraine includes:</i> • <i>Plasma and platelet concentrations of 5-HT vary with the different phases of the migraine attack</i> • <i>Urinary concentrations of 5-HT and its metabolites are elevated during most migraine attacks</i> • <i>Migraine may be precipitated by agents (e.g., reserpine and fenfluramine) that release 5-HT from intracellular storage sites</i> ➤ <i>Consistent with the 5-HT hypothesis, 5-HT receptor agonists have become a mainstay for acute treatment of migraine headaches. Treatments for the prevention of migraines, such as adrenergic antagonists and newer anti-epileptic drugs, have mechanisms of action that are, presumably, unrelated to 5-HT</i>

Prise en charge de la crise migraineuse



PEC de la crise :
Reco du Vidal

➤ TTT de la crise :

- Le + précoce possible
- **Non spécifique (antalgique +/- antiémétique, AINS) ou spécifique (triptan, dérivé ergoté, DHE spray, ergotamine)** selon intensité de la crise et efficacité des médicaments lors des crises antérieures
- Si crise avec aura : attendre le début de la céphalée => **triptans** ou **dérivés ergotés**

➤ Évaluation du TTT après 2h :

- Si soulagement et bonne tolérance après 1 prise unique : **TTT non modifié**
- Si patient migraineux connu et TTT non spécifique inefficace, et/ou plusieurs prises, et/ou mauvaise tolérance, et/ou reprise d'activité retardée et anormale :
=> crise suivante à traiter par **AINS d'emblée**
=> **et triptan** si Ø de soulagement 2h après la prise d'AINS
- **Dérivés ergotés** chez patients non répondeurs au triptans
- Médicaments associant caféine + paracétamol ou aspirine : non recommandés (risque abus)
- Éviter opioïdes seuls ou associés : risque d'abus voire addiction

➤ Évaluation de la fréquence des crises :

- Agenda des crises pdt 6 mois (date survenue, durée, intensité douleur, TTT)
- Comptabiliser les prises mensuelles d'antimigraineux, spécifiques ou non => abus

Stratégie pharmacologique de crise : objectif

Objectif principal : ↘ sévérité et durée de la crise migraineuse

➤ Médicament de la crise :

- Soit **antalgiques** (aspirine, AINS)
- Soit **antimigraineux spécifiques** (dérivés ergotés, agonistes 5HT_{1B/D} de la sérotonine)
- **Antiémétiques** fréquemment associés => soulager troubles digestifs (nausées/vomissements) fréquents au cours de la crise

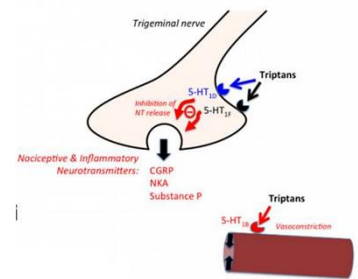
	➤ Ces médocs agissent essentiellement sur la composante céphalique de la crise ➤ Aucun de ces médocs n'est efficace sur l'aura, mais peuvent améliorer les signes associés : • Photophobie • Phonophobie • Tb dig • Incapacité fonctionnelle ➤ Ces médoc peuvent être responsable de la survenue de céphalées chroniques quotidiennes si abus ➤ Les antalgiques et AINS : • Luttent vs la douleur et réaction inflammatoire méningée • Médocs faisant l'objet d'une automédication intense et peuvent déterminer en cas de prise trop fréquente, une modification de la fréquence des crises => céphalée quotidienne chronique (CCQ) dont la PEC est proche de celle des pharmacodépendances ➤ Les agonistes des Rc 5HT1B/D = les Triptans : • Chef de file : Sumatriptan (Imigrane®) • Action : vasoconstriction des artères méningées et cérébrales anormalement dilatées par les phénomènes ayant conduit à la céphalée migraineuse • Formes galénique variable selon le patient : SC, VO, pulv nasale (si tb dig par ex)... ➤ Les dérivés ergotés : (tartrate d'ergotamine et mesilate de dihydroergotamine, DHE) • A la fois des agonistes des Rc α-adrénergiques et des Rc 5HTAB/D de la sérotonine • DHE : seule la forme per nasale est disponible
Antalgiques et AINS : TTT non spécifiques de la crise de migraine	
Antalgiques	➤ Paracétamol (Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan®) ➤ Amidopyrine (Optalidon®) : dérivé pyrazolé (agranulocytose)
AINS	<i>Inhibition de la cyclo-oxygénase (COX)</i> ➤ Acide acétylsalicylique (Aspirine®, Kardégic®) : • Résorption diminuée pdt la crise • +/- Métoclopramide (Cephalgan, Migpriv®) = stimulant la motricité intestinale ➤ AINS : pas l'indication du TTT de la migraine • Naproxène (Apranax®, Naprosyne®) • Indométacine (Indocid®) ➤ Pour les EI, et interaction => cf. cours spécifiques (douleur, hémato...)
Nb	➤ Surtout efficace sur la céphalée ➤ Ils pourraient agir sur la réaction inflammatoire locale de la méninge secondaire à la vasodilatation des artères méningées

Triptans :

TTT spécifiques de la crise de migraine

Agonistes des Rc 5HT_{1B/D} de la sérotonine

Proposed Mechanisms for Triptan Effect on Migraine



Propriétés

➤ Effets pharmacologiques :

- Agoniste 5HT_{1B/D} sélectif sur les territoires vasculaires méningés => **vasoconstriction**
- Et **inhibition libération de facteurs vasodilatateurs** (peptide CGRP, VIP et sbs P)
=> vasoconstriction artérielle
=> inhibition activation syst trigémino-vasculaire
=> inhibition transmission message nociceptif trigéminal

/!\ Rc 5HT_{1B/D} aussi présents au niveau coronaire => **risque d'ischémie myocardique** chez patients à risque

➤ Devenir dans l'organisme :

- Bonne biodispo en SC (douleur au pt d'injection)
- Biodispo médiocre per os
- New triptans : meilleure lipophilie, pic + rapide, action + longue
- Délai d'action court en SC (20 min)
- Elimination rapide (1/2 vie 2h en moyenne)

➤ EI :

- Mineurs et transitoires (15 min-2h)
- Vasoconstriction artérielle => risque de **spasme coronarien**
- **Oppression**/chaleur thoracique, faciale, nuchale (Sumatriptan)
- Signes sérotoninergiques : **tb digestifs** (nausées, gastralgies)
- Somnolence, **asthénie**, paresthésie, vertiges

➤ IM :

- Médoc à activité 5HT (IMAO, ISRS, **dérivés de l'ergot** de seigle)
- => **syndrome 5HT** :
 - Apparition (+/- brutale, simultanée ou séquentielle) d'un ensemble de symptômes pouvant nécessiter une hospitalisation voire la mort
 - **Symptômes psychiques** : agitation, confusion, hypomanie, voire coma
 - **Symptômes végétatifs** : hypotension/hypertension, tachycardie, frissons, hyperthermie, sudation
 - **Symptômes moteurs** : myoclonies, tremblement, hyperréflexie, rigidité, hyperactivité
 - **Symptômes digestifs** : diarrhée

➤ CI :

- Infarctus du myocarde, cérébral, angor
- Tb du rythme cardiaque (WPW)
- TTT contenant de l'ergotamine et 5HT

Molécules	➤ <u>Sumatriptan SC</u> : Imigrane®, Imiject® • Crise de migraine, algies vasculaires de la face • Ampoule 6 mg, 1 injection/crise (possible 2^{ème} injection, 1h d'intervalle) ➤ <u>Sumatriptan spray nasal</u> : • Imigrane (ampoule à 10-20 mg) • Max 2 ampoules de 20 mg/j, 2h d'intervalle) ➤ <u>Sumatriptan per os</u> : • Imigrane CP à 50-100 mg • Max 300 mg/j ➤ <u>Zolmitriptan</u> : • Zomig® CP 2,5 mg • Max 5 mg/j, 2h d'intervalle ➤ <u>Naratriptan</u> : • Naramig® CP 2-5 mg/h • Max 5 mg/j, 4h d'intervalle
Dérivés ergotés : <i>TTT spécifiques de la crise</i>	
Propriétés	➤ Tartrate et Dihydro-ergotamine ➤ TTT précoce, quand le sujet sent la crise arriver (prodromes) ➤ <u>Effets pharmacologiques</u> : • Effet vasoconstricteur sur artères extracrâniennes (stimulation 5-HT) • Agoniste partiel 5-HT, NA : => vasoconstriction des artères extracrâniennes (5-HT) => vasoconstriction sur artères périphériques (NA) => veinospasme (effets alpha-stimulation) => fermeture de Shunt artérioveineux => stimulation area postrema et centre du vomissement => <u>action émétisante</u> ➤ <u>Devenir dans l'organisme</u> : • Per os : résorption mauvaise • Stase gastrique pdt la crise + first-pass hépatique important => faible biodispo et grande variabilité inter-indiv • Association avec caféine ↗ biodisponibilité
Molécules	➤ <u>Tartrate d'ergotamine</u> = Gynergène caféiné • Pas en TTT continu (risques effet vasoconstricteur) • Per os CP 1 mg / suppo 2 mg : 1-2 mg en début de crise • Peut être renouvelé 30 min + tard si crise persiste • Max 6 mg/j, 10 mg/semaine (risque ergotisme) ➤ <u>Dihydroergotamine</u> = Diergo Spray® • Voie parentérale (0,5-1 mg IM ou IV) • Spray nasal (résorption ++ rapide : 1-2 mg)

Retour sur les médicaments de la crise migraineuse

Effets PD utiles

- Tous les médocs de la crise : surtout efficaces sur la céphalée migraineuse
- Ø effet sur l'aura migraineuse => reco d'attendre début phase algique pour admin ces TTT
- Ce sont des médocs symptomatiques de la crise d'où les récides au bout de qqes h
- **Triptans :**
 - Capables de ↘ l'intensité des tb associés à la migraine (tb dig, photophobie, phonophobie)
 - Et capables de ↘ l'incapacité fonctionnelle induite par la crise

Effets PK utiles

- **Dérivés ergotés :**
 - Faible biodispo imposant pour la DHE, l'usage de la voie per-nasale
 - Longue ½ vie : favorisant l'accumulation du médoc en cas d'usage trop freq
 - Ne doivent pas être prescrits à des patients ayant > 1 crise/semaine (risque ergotisme chronique)
 - Métabolisés par CYP3A4 : ne doivent pas être associés à des inhibiteurs de CYP450 (antifongiques azolés, anti-protéases VIH « -navir », macrolides, jus pamplemousse) => risque accumulation et ergotisme aigu
- **Agonistes Rc 5-HT1B/D de la sérotonine :**
 - Généralement bonne absorption orale
 - SAUF Sumatriptan (intérêt des formes parentérales)
 - ½ vie variable mais souvent courte => d'où haute fréquence des récides migraineuses dans les h suivant la 1^{ère} crise
 - Maj sont des substrats de la MAO-A d'où la CI d'association au IMAO

Précautions d'emploi

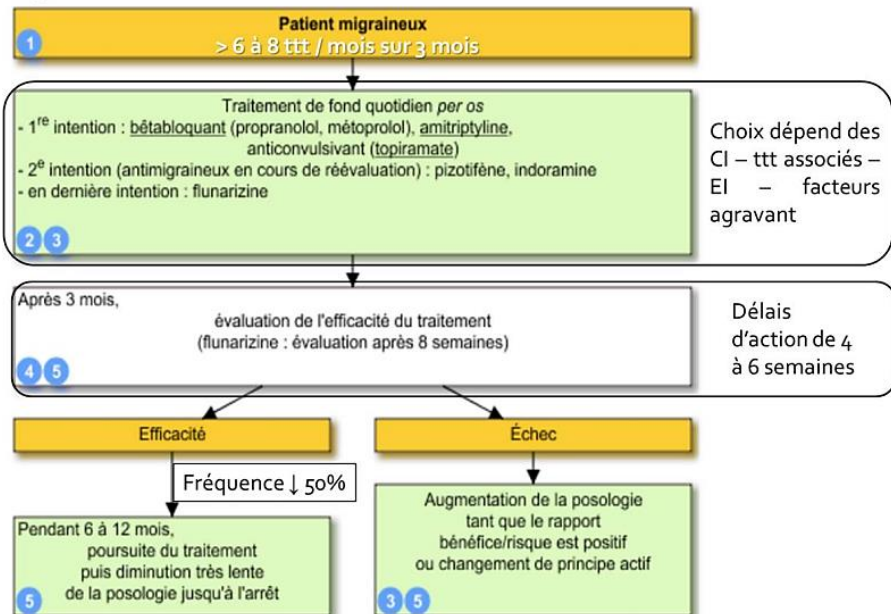
- **Ergotés de la crise et agonistes Rc 5HT1B/D de la sérotonine : vasoconstricteurs**
=> ne doivent pas être prescrit à des patients connus/suspect de cardiopathie ischémique
=> dans le doute => réaliser un bilan approprié avant chaque prescription
- CI antimigraineux chez patients souffrant de céphalées autres que la migraine
- Cependant, certains antimigraineux sont indiqués dans **TTT algie vasculaire de la face**

Classe ou molécule	Nature de l'effet	Gravité
Agonistes 5HT1B/D	Effets généraux	Facile à modéré
	CV	Potentiellement grave
	SNC	Faible à modérée
	Digestifs : <i>Nausées, vomissements...</i>	Faible
	Oculaires : <i>Scotome, diplopie, amblyopie...</i>	Modérée
	Réaction allergique	Potentiellement grave
	Liés au mode d'admin	Faible
Dérivés ergotés	Digestifs : <i>Nausées, vomissements</i>	Faible
	CV	Potentiellement grave
	Ergotisme chronique et aigu	Potentiellement grave
	Liés au mode d'admin	Faible

EI (Fréquents mais souvent peu graves)	➤ <u>Agonistes des Rc 5HT1B/D</u> : « syndrome des Triptans » • Survenue et sévérité de EI : dose-dépendante • EI conditionnés par forme galé : formes inj (Sumatriptan) ou per nasale (Sumatriptan et Zolmitriptan) : absorption + rapide et EI + intenses et fréquents • EI cardiovasculaire : - Car présence de <u>Rc de la sérotonine</u> sur les artères coronaires => vasoconstriction - Donc prudence/éviter de prescrire ces médicaments si patient avec ATCD cardiopathie ischémique ou à risque CV établi ➤ <u>Dérivés ergotés de la crise</u> : Tartrate d'ergotamine (VO) et DHE (per nasale) • EI digestifs chez tous les ergotés : liés à struct chim (action sur la chemo-trigger zone) • EI cardiovasculaires (++) formes parentérales) : liés à affinité pour <u>Rc α adrénergiques</u>
Variabilité de la rep pharmacologique	➤ <u>Liés à la crise</u> : • Tb digestifs (nausées, vomissements) : peuvent modif la cinétique (et donc l'effet antimigraineux) de tous les médoc de la crise => recours à des formes autres que la VO (IV, SC, per nasale) • Délai de la prise par // début de la crise : une prise tardive favorise l'inefficacité et prolonge inutilement la durée céphalée et du handicap • Présence aura : attendre l'apparition de la céphalée lors d'une crise avec aura • Prise trop fréquente de médicaments de la crise (y compris antalgiques et AINS) : modif la symptomatologie et favorise survenue d'une <u>céphalée chronique quotidienne</u> (CCQ) avec une véritable pharmacodépendance ➤ <u>Liés au médicament</u> : • Forme pharmaceutique : conditionne intensité et rapidité de réponse (+ rapide si voies non orales) • Biodisponibilité : déterminant pour l'intensité et rapidité de réponse - Sumatriptan : absorption médiocre et variable d'une prise à l'autre => d'où reproductibilité de la rep médiocre - Médocs dont absorption lent (Naratriptan, Almotriptan) : délai d'action + long sur la céphalée qu'avec autres mol avec absorption + rapide • ½ vie : récurrence des crises directement reliée à la ½ vie - ½ vie longue (dérivés ergotés) : fréquence des récurrences moindre - ½ vie courte (triptans) : récurrences fréquentes

Prise en charge de fond

Migraine : traitement de fond



PEC de fond : Reco du Vidal

- Quand migraine (fréquence + intensité) retentit sur vie quotidienne
=> abus antalgiques ou de dérivés d'ergot
- **2 crises violentes ou 5 crises/mois**
- Choix :
 - Selon les TTT antérieurs (efficacité, tolérance, durée TTT, automédications)
 - Selon sévérité et fréquence des crises
- Tenir compte des précautions d'emploi et CI
- Rechercher la poso optimale (progression des doses)
- **Durée de TTT suffisante** pour juger l'efficacité : **2-3 mois**
- **Durée du TTT** selon sévérité de la migraine : **4-6 mois si efficace**,
Puis ↘ *progressive pour poso minimale ou arrêt*
- Céphalées induites par les abus d'antimigraineux :
 - Souvent interprétées comme récives
 - Disparaissent après sevrage
 - Réévaluation thérapeutique quand exacerbation des céphalées entraînant une surconso d'antimigraineux
- Indication d'un TTT de fond :
 - Analyse des crises (fréquence, intensité, sévérité, qualité de vie) et conso médoc (> 6-8 prises mensuelles depuis 3 mois, même efficaces)
 - Agenda de migraine et questionnaire de qualité de vie
- Mise en route du TTT :
 - Expliquer le délai d'action (4-6 semaines) et l'objectif : ↘ fréquence ou intensité crises (suppression complète des crises = exceptionnelle)
 - Commencer par monothérapie, faible dose, progressivement croissante

	➤ <u>Choix du TTT :</u> • Ø mol supérieure/autre • Choix du TTT selon CI, TTT associés, EI, facteurs aggravants de la fréquence des crises : stress et émotions fortes incitent - Stress, émotions => utiliser β-bloquants - Anxiété et dépression => Amitriptyline • Ø intérêt d'associer 2 TTT de fond ➤ <u>Evaluation du TTT après 3 mois :</u> • TTT de fond jugé efficace si fréquence des crises réduite de 50% • Et si crises – sévères et/ou – longues ➤ <u>Crises au décours d'un TTT de fond :</u> • Association Triptan + dihydroergotamine ou + méthylsergide = CI ++ • Si crises récidivent 6-12 mois après arrêt d'un TTT de fond efficace => reprendre même TTT de fond ➤ <u>Migraine résistante :</u> • Méthylsergide : réservé aux migraineux résistants aux autres TTT, prescrits avec fenêtres thérapeutiques de 1 mois tous les 6 mois • Flunarizine utilisée après échec des autres TTT, pour durée < 6 mois
Stratégie pharmacologique de fond	<i>Objectif principal : ↘ fréquence des crises (+/- ↘ sévérité ou durée crise ou amélioration de la rep de la crise au TTT)</i> ➤ TTT de fond prophylactique PAS systématiquement prescrit ➤ Certains médocs limitent l'usage simultané de médoc efficaces de la crise (dérivés ergotés) ➤ Impossible de classer les médocs du TTT de fond selon leur méca d'action (hypothétique) ➤ <u>On distingue cependant :</u> • Antago des Rc béta-adrénergiques • Antago des Rc sérotonine • Dérivés ergotés • Inhibiteurs des courants calciques • Antiépileptiques <i>Nb : dans ces familles seules certaines mol ont une efficacité démontrée ou une indication précisée dans l'AMM</i> ➤ + récemment, les AC monoclonaux dirigés vs le Rc au calcitonin gene-related peptide (CGRP) ont démontré une certaine efficacité ➤ <u>En pratique, le choix d'un antimigraineux est :</u> • Conditionné par le terrain • Limité par le risque d'EI (les + communs : sédation et modif de l'appétit) ➤ <u>Effet d'un TTT de fond antimigraineux :</u> • PAS immédiat • Demande ≈ 2 mois pour s'installer • Efficacité admise s'il ↘ de 50% la fréquence des crises : d'où l'importance de la tenue d'un agenda de crise par le patient • Peut être poursuivi pdt 6 mois-1 an • Arrêt progressif • Reprise du TTT de fond si fréquence des crises ↗ à nouveau

➤ Démonstration de l'efficacité de la maj des médocs de fond :

- Fruit du hasard pour la plupart
- Aucun pt commun démontré dans le mécanisme d'action
- Certains médocs efficaces n'ont pas d'AMM dans cette indication
- Classement des mol selon 3 catégories : efficacité démontrée, probable, douteuse

Efficacité démontrée	Efficacité probable	Efficacité douteuse
Métoprolol (AMM) Propranolol (AMM) Topiramate (AMM) Valproate de sodium	Amitriptyline Aténolol Candésartan Flunarizine (AMM) Nadolol Naproxène sodique Nébivolol Oxétorone (AMM) Pizotifène (AMM) Timolol Venlafaxine	Gabapentine

Les sympatholytiques

β-Bloquants

- **Propranolol** (Avlocardyl®, Hemipralon)
- **Métoprolol** (Seloken®, Lopressor®)

=> *dépourvus d'activité sympathomimétique intrinsèque*
=> *sélectivité Rc β1/β2 : ∅ importance*
=> *médocs de ref pour le TTT de fond*

- Action prophylactique par **maintien tonus vasoconstricteur** (bloque effet bêta-dilatateur, prédominance effet alpha)
- Blocage synthèse thromboxane A2
- Pharmac, EI, CI => cf. *cours spécifique bêtabloquants*
- Poso Propranolol : 80-160 mg/j, en 2 prises
- Durée TTT : au moins **3-4 mois**

Les inhibiteurs calciques

Anticalciques

- **Flunarizine** (Sibélium®)
=> seul anticalcique ayant des propriétés antimigraineuses
=> **Vérapamil**, lui, est uniquement efficace dans le TTT de fond de l'algie vasculaire faciale
- Effets :
 - Effet **anticalcique**
 - Effet **antihistaminique**
 - Effet **sérotoninergique**
 - Effet **dopaminergique** : antago des Rc dopaminergique (neuroleptique cachés)
- EI :
 - Somnolence, prise de poids
 - Syndrome parkinsonien, dyskinésie tardives dépression

Les antidépresseurs/antiépileptiques	
Antidépresseurs	➤ Efficacité par complètement démontrée/confirmée ➤ <u>Antidépresseurs tricycliques :</u> • Amitriptyline (Laroxyl®) : 10-60 mg/j => Maintien de l'effet jusqu'à 30 semaines • Clomipramine (Anafranil®) : 10 mg/j
Antiépileptiques	➤ <u>Seuls 3 médicaments ont prouvé leur efficacité au cours d'essais cliniques :</u> • Topiramate (Epitomax®) • Valproate de sodium • Gabapentine ➤ Aucun n'a d'AMM en France pour cette indication
Antagonistes des Rc 5-HT2	
Nb	➤ <i>Considérés comme des vasodilatateurs</i> ➤ <i>MAIS il s'agit de mol dérivant des antidépresseurs tricycliques ayant une affinité pour plusieurs Rc autres que les Rc 5-HT2 => d'où leur EI</i> ➤ <i>Ce sont des antago des Rc muscariniques ==> effets atropiniques</i> ➤ <i>Tous ces médicaments sont des antago des Rc histaminiques H1 et ont des effets sédatifs et orexigènes</i>
Méthylsergide (Désernil®)	➤ <u>Effets :</u> • Antago 5-HT2 : inhibe vasoconstriction induite par 5-HT • Inhibe agrégation plaquettaire induite par 5-HT • Agoniste partiel 5-HT sur Rc du tronc cérébral ➤ <u>EI :</u> • Tb digestifs, sensation de malaise • Effet anti-H1 : somnolence diurne ou insomnie • Fibrose rétropéritonéale (cures < 6 mois et non répétées, sinon intervalle 3-4 semaines) ➤ Poso progressive, doses efficaces par tâtonnement
Pizotifène (Sanmmigran®)	➤ Dose 3-4 cp/j (poso croissante) ➤ <u>EI :</u> • Effet anti-H1 : somnolence • Constipation • Prise de poids
Oxétorone (Nocertone®)	➤ Effet anti-H1 : somnolence

Dérivés ergotés	
Avis défavorable	➤ <u>Dihydroergotamine</u> : • Dergotamine®, DHE Lafarge®, DHE Sandoz, Ikaran®, Seglor®... • Agoniste partiel : 5-HT + alpha (+ marqué sur la circulation veineuse) • A forte doses, bloque les Rc 5-HT et alpha • Poso : 9 mg/24h, en 3 prises La commission d'AMM considère que le rapport bénéfice/risque de la dihydroergotamine est défavorable dans le traitement de fond de la migraine, l'hypotension orthostatique et l'insuffisance veino-lymphatique. En effet, les données d'efficacité sont insuffisantes au regard des standards d'évaluation et son emploi présente un risque potentiel pour le patient. Notamment, même si celles-ci sont rares, des réactions fibrosantes cardio-thoraciques ou rétropéritonéales (formation pathologique de tissu fibreux au niveau d'organes vitaux comme le cœur, les poumons, la paroi thoracique et le péritoine) ont été observées. Par ailleurs, d'autres dérivés de l'ergot de seigle (dihydroergotoxine, dihydroergocornine, dihydroergocristine, dihydroergocryptine, nicergoline et méthysergide) font actuellement l'objet d'une réévaluation de leur rapport bénéfice/risque au niveau national ou au niveau européen. En ce qui concerne la dihydroergotamine indiquée dans le traitement de la crise migraineuse (spray nasal et forme injectable) le rapport bénéfice/risque reste favorable.
Retour sur les médicaments de fond de la crise migraineuse	
Effets PD utiles	➤ Tous les médocs des TTT de fond de migraine ↘ la fréquence des crises (et/ou ↘ sévérité et/ou durée) ➤ En l'absence d'études comparatives : absence de préférences d'un médoc par rapport à un autre ➤ Choix du médoc dépend donc du terrain et des TTT reçus antérieurement par le patient ➤ <u>1^{ère} intention du TTT de fond</u> : • β-bloquants • Oxétorone • Amitriptyline ➤ <u>2^{ème} intention du TTT de fond</u> : • Pizotifène • Flunarizine • Valproate de sodium • Gabapentine
Effets PK utiles	➤ <u>Antago des Rc 5-HT₂ de la sérotonine</u> : • Pizotifène et Oxétorone • ½ vie permettant 1 admin/j, le soir de préférence (<u>effets sédatifs</u>) ➤ <u>Antago calciques</u> : • Flunarizine • ½ vie longue : d'où longue rémanence des EI (syndromes extrapyramidaux, dépressifs)
Précaution d'emploi /EI	➤ <u>Prescription ne doit PAS être systématique MAIS réservée aux patients</u> : • Ayant un nb suffisant de crises (> 2-3/mois) • Ou chez qui le TTT de crise n'est pas suffisant

- But du TTT doit être clairement expliqué (idem pour le délai d'efficacité du TTT) au patient
- Les autres médicaments sont prescrits avec précaution chez :
 - Patients en surpoids/obèses (prévoir surveillance régulière du poids) : car effet orexigène (antisérotinines, Flunarizine, +/- antiépileptiques)
 - Patients ayant une CI aux atropiniques (antisérotinines)
- Nbreux EI dont certains doivent être systématiquement pris en compte lors choix TTT :
 - **Prise de poids** : ++ avec antisérotinines, la Flunarizine et le Valproate de sodium, modif de l'appétit avec grignotage et appétence particulière pour aliment sucrés
=> surveillance régulière du poids avant et pdt la durée du TTT
 - **Sédation** : ++ avec antisérotinines, la Flunarizine et antiépileptiques
=> limitation à une prescription vespérale dans certains cas
=> doit être prise en compte pour la conduite automobile
 - **Limitation à l'effort** : avec β -bloquant (+ $\surd$ FC), peut être gênante pour certains patients jeunes et ayant une activité physique importante

Classe ou molécule	Nature de l'effet	Gravité
β-bloquants	CV	Potentiellement graves
	SNC	Modérée
Antisérotinines	SNC	Modérée
	Digestifs	Modérée
	Effets atropiniques	Modérée
Flunarizine	Sédation, prise de poids	Modérée
	Syndrome dépressif	Potentiellement grave
	Syndrome extrapyramidal	Potentiellement grave
Antiépileptiques	Digestifs, hépatiques	Potentiellement grave
	SNC	Modérée
	Prise de poids	Modérée

Variabilité de la rep pharmacologique

- Totalement imprévisible
- Rep à ces médicaments dépend essentiellement de l'observance :
=> maj échecs des TTT de fond seraient à mettre sur le compte d'une mauvaise observance
- Choix du médicament repose + sur l'histoire du patient et le terrain que sur la migraine
- MAIS les β -bloquants peuvent parfois aggraver la migraine avec aura :
=> une introduction progressive permet (souvent) de limiter les EI (amélioration observance)
- Effets médicaments TTT de fond :
 - Nécessitent **plusieurs semaines de TTT** bien suivi avant de devenir notables
 - Appréciation subjectifs du patient sur les effets => d'où fixation d'objectifs lors prescription
 - Et vérif de l'effet par analyse d'un agenda des migraines (++) bien tenu)